

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

**Consent Information – Patient's Copy
Embolisation – Uterine Artery (EUA)**

**معلومات الإقرار – نسخة المريض
الانصمام (إغلاق الشريان الرحمي)**

1. What is an Embolisation of the Uterine Artery?

Embolisation of the uterine arteries is a procedure that blocks the blood vessels that supply blood part of the uterus. The blood supply to your uterus is blocked by a material called an 'embolic agent'. There are many different types of embolic agents including coils, foam and particles. Your doctor will choose the one best suited to your condition. More than one embolic agent may be used. The embolisation catheter is done by placing a needle and a thin plastic tube into the artery in your groin. Iodinated Contrast Media (once called x-ray dye) is used during the procedure to map your arteries so the doctor can locate and treat your uterine artery. If more information on Iodinated Contrast Media is required please request.

2. Will there be any discomfort, is any anesthetic needed?

This procedure will require an injection of local anesthetic and a sedation anesthetic.

3. What is sedation?

Sedation is the use of drugs that give you a 'sleepy-like' feeling. It makes you feel very relaxed during a procedure that may be otherwise unpleasant or painful. You may remember some or little about what has occurred during the procedure.

This procedure may only have a light sedation. You need to be able to fully co-operate at times by holding your breath when instructed by the doctor.

Sedation is generally very safe but has a risk with side effects and complications. Whilst these are usually temporary, some of them may cause long-term problems.

The risk to you will depend on:

- Whether you have any other illness.
- Personal factors, such as whether you smoke or are overweight.

4. Preparation for the procedure

The Medical Imaging Department will give you instructions on how to prepare for your procedure.

You will be told when to have your last meal and drink. This is to make sure your stomach is empty so that if you vomit during the procedure there will be nothing to go into your lungs.

Please tell the staff if you are or suspect you might be pregnant or are breastfeeding.

If you take Aspirin, Warfarin, Clopidogrel (Plavix and Iscover) or Dipyridamole (Persantin and Asasantin) or any other drug that is used to thin your blood ask your doctor/health practitioner if you should stop taking it before

1. ما هو (الانصمام (إغلاق الشريان الرحمي)؟

انصمام (إغلاق – سد) الشريان الرحمي هو إجراء يتم فيه سد وإغلاق الأوعية الدموية التي تغذي الرحم. يتم إغلاق التغذية الدموية للرحم باستخدام مادة تسمى "مادة الانصمام". توجد أنواع عديدة من هذه المادة ومن ضمنها الخيوط المعدنية اللولبية ، الرغوة ، الجسيمات. يقوم طبيبك باختيار الوسيلة المناسبة لعلاج حالتك المرضية. قد يتم استخدام أكثر من نوع من مادة الانصمام. يجري الانصمام (إغلاق الوعاء الدموي) بوضع إبرة و أنبوب بلاستيكي رقيق (قسطرة) في شريان بمنطقة أعلى الفخذ .

تستخدم مادة الوسط المتباين المعالجة باليود (تسمى سابقاً صبغة الأشعة السينية) في هذا الإجراء لرسم خريطة لشرايينك مما يمكن الطبيب من تحديد وعلاج الشريان الرحمي.

للمزيد من المعلومات عن مادة الوسط المتباين المعالجة باليود والمخاطر المرتبطة بها ، نرجو قراءة ورقة معلومات المريض المتعلقة بمادة الوسط المتباين المعالجة باليود (إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها).

2. هل سيكون هناك شعور بعدم الراحة ؟ هل هناك حاجة لأي دواء تخدير؟

سيطلب القيام بهذا الإجراء إعطائك حقنة مخدر موضعي و دواء مسكن .

3. ماذا يعني التسكين (إعطاء دواء مسكن)؟

هو إعطاء دواء يعطيك شعور بالنوم ويجعلك مسترخ جداً خلال الإجراء ، حيث أن القيام بهذا الإجراء دون إعطاء مسكن قد يكون مزعج ومؤلم. قد تكون لديك القدرة لتذكر بعض مما حدث أثناء القيام بالإجراء. في هذا الإجراء تعطى مسكن خفيف . من المهم أن تكون أن تكون قادراً على التجاوب التام مع الطبيب عندما يطلب منك حبس النفس. الدواء المسكن بشكل عام آمن ، إلا أن له مخاطره وآثاره الجانبية و مضاعفاته ، وعلى الرغم أن غالبيتها تكون مؤقتة ، إلا أن البعض منها قد تكون له مشاكل طويلة الأمد. المخاطر بالنسبة لك تتوقف على:

- إذا كنت مصاب بأمراض أخرى .
- عوامل شخصية مثل التدخين أو زيادة الوزن.

4. التحضير للإجراء

سيقوم قسم الأشعة والتصوير الطبي بإعطائك تعليمات متعلقة بالتحضير لهذا الإجراء.

سيتم إبلاغك بأخر موعد يمكنك فيه تناول الطعام والشراب لأنه من المهم أن تكون معدتك فارغة أثناء الفحص ، لتلافي أي تقيؤ قد يؤدي إلى دخول المادة المتقنية إلى الرئتين.

نرجو إبلاغ الموظفين إن كنت حاملاً أو تشكين في كونك حاملاً أو تمارسين الرضاعة الطبيعية.

إن كنت تتناول أيّاً من الأدوية التي تزيد من سيولة الدم كالأسبرين وارفارين ،كلوبيدوجريل(بلافيكس أو اسكوفير) أو دايابيردامول(بيرسانتين أو اساسانتين) أو أي عقار آخر لنفوس الغرض ، فاسأل طبيبك إن كان عليك التوقف عن تناولها قبل الإجراء لأنها قد تؤثر على تخثر دمك.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

the procedure as it may affect your blood clotting.

List or bring all your prescribed drugs, those drugs you buy over the counter, herbal remedies and supplements.

Do not drink any alcohol and **stop recreational drugs** 24 hours before the procedure as they may alter the affects of the sedation anesthetic. If you have a drug habits please tell your doctor. **(These activities are forbidden by Shariah Law).**

5. During the procedure

A fine needle (IV cannula) will be put into a vein in your arm and you will be given the sedation anesthetic.

The Radiologist (x-ray doctor) will inject local anesthetic into the skin. A needle and catheter are inserted into the artery in your groin; sometimes your arm may be used. Once the catheter is in place the needle is removed.

X-ray images are taken while the contrast is injected into your arteries.

The catheter is guided through the main blood vessels in your body until it reaches your uterine artery. You should not be able to feel the catheter inside your body.

X-ray images are taken while the contrast is injected into your arteries

Once the catheter is in place the embolic agent is injected into the artery. Several injections of the embolic agent may be needed to completely block off the artery.

Once the uterine artery is completely blocked, the catheter will be removed. Firm pressure will be put over the area where the catheter went into your skin (puncture site). This allows the artery to seal so you will not bleed.

6. After the procedure

The recovery time after the procedure varies between 4 to 6 hours. You will need to lie flat and keep your leg (or arm) still and straight. Moving too soon after this procedure may cause bleeding at the puncture site.

The IV cannula will be removed after you have recovered.

Most patients experience Post Embolisation Syndrome which includes pain, nausea, vomiting and fever. It is due to the blood supply to the treated area being cut off. You will be able to go home once your pain and nausea have settled, usually within 2 days. It is normal to have a fever for up to a week after the procedure. Staff will discuss with you the need to *restrict your activities* at home for up to 5 days. Follow these instructions carefully.

7. What are the risks of this specific procedure?

The risks and complications with this procedure can include but are not limited to the following.

احضر معك كل الأدوية الموصوفة لك ، والأدوية التي تتناولها دون وصفة ، والعلاجات العشبية والعلاجات التكميلية أو احضر قائمة بها.

لا تحتسي الكحوليات وأوقف تعاطي كل الأدوية والعقاقير الترفيهية التي تتناولها، وذلك قبل 24 ساعة من الإجراء ، لأنها قد تتداخل مع عمل الدواء المسكن. إذا كنت معتاداً على عقار معين، نرجو إبلاغ الطبيب. **(تعتبر هذه الأنشطة محرمة وممنوعة من قبل القانون السعودي القائم على أساس الشريعة الإسلامية).**

5. خلال الإجراء

يتم وضع حقنة رفيعة في أحد أوردة ذراعك (خط وريدي) وسوف تعطى دواء مسكن.

يقوم طبيب الأشعة بحقن مخدر موضعي في الجلد . يتم إدخال إبرة وقسطرة رفيعة في الشريان بمنطقة أعلى الفخذ ، في بعض الأحيان يستخدم وريد في الذراع. تزال الإبرة بعد إدخال القسطرة إلى موقعها المحدد.

تؤخذ صور بالأشعة السينية بينما يتم حقن مادة الوسط المتباين في الشرايين.

تمرر القسطرة داخل الأوعية الدموية الرئيسية في الجسم حتى تصل إلى الشريان الرحمي. من المفترض عدم شعورك بالقسطرة داخل جسمك.

تؤخذ صور بالأشعة السينية بينما يتم حقن مادة الوسط المتباين في الشرايين.

ما أن توضع القسطرة في موضعها المحدد حتى يتم حقن مادة الانصمام في الشريان . قد تكون هناك حاجة لاعطاء العديد من حقن مادة الانصمام لإغلاق الشريان بشكل كامل.

ما أن يتم إغلاق الشريان الرحمي بشكل كامل ، حتى تتم إزالة القسطرة. يوضع ضغط قوي على الجلد في منطقة دخول القسطرة ، وتستخدم أحياناً سدادة معينة. يؤدي ذلك إلى إحكام إغلاق الشريان لمنع حدوث نزيف من منطقة إدخال القسطرة.

6. بعد انتهاء الإجراء

فترة النقاهة بعد هذا الإجراء تتراوح ما بين 4-6 ساعات . سيطلب منك الاستلقاء مسطحاً على ظهرك مع إبقاء ساقك (أو ذراعك) ممدودة وفي حالة سكون (ثابت) لمدة 4-6 ساعات. التسرع في الحركة بعد الإجراء قد يسبب نزيف من موضع إدخال القسطرة. يزال الخط الوريدي بعد الانتهاء من فترة النقاهة التي تعقب الإجراء.

تعاني أغلبية المرضى مما يعرف بـ "متلازمة ما بعد الانصمام" وتشمل ألم ، غثيان ، تقيؤ ، وارتفاع في درجة الحرارة. وسبب ذلك هو انقطاع الدم عن المنطقة التي تمت معالجتها.

سيكون بمقدورك العودة للمنزل بمجرد توقف الألم والغثيان ويكون ذلك عادةً خلال يومين . من الطبيعي أن يعاني المريض من ارتفاع في درجة الحرارة لمدة أسبوع بعد الإجراء. سناقش معك العاملون في القسم ضرورة الحد من الأنشطة المنزلية للخمسة الأيام الأولى التي تعقب الإجراء. اتبع هذه التعليمات بكل دقة.

7. ما هي مخاطر هذا الإجراء بالتحديد؟

المخاطر و المضاعفات المرتبطة بهذا الإجراء تشمل ، ولكنها غير محصورة في :

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Common risks and complications include:

- Minor pain, bruising and/or infection from the IV cannula. This may require treatment with antibiotics.
- Pain or discomfort at the puncture site. This may require medication.
- Bleeding or bruising may occur. This is usually stopped by applying pressure and/or ice to the puncture site. This is more common if you take Aspirin, Warfarin, Clopidogrel (Plavix and Iscover) or Dipyridamole (Persantin and Asasantin).
- Post Embolisation Syndrome which includes pain, nausea, vomiting and fever. Antibiotics and pain relief medications will be required to treat this.
- Failure of local anesthetic which may require a further injection of anesthetic or a different method of anesthesia may be used.
- Nerve damage, is usually temporary, and should get better over a period of time. Permanent nerve damage is rare.

Less common risks and complications include:

- Infection, requiring antibiotics and further treatment.
- Damage to surrounding structures such as blood vessels, organs and muscles, requiring further treatment.
- A blood clot or excessive bleeding from the puncture site. This may require other treatment and/or corrective surgery.
- An allergy to injected drugs, requiring further treatment.
- Tissue breaking off the uterine wall into the uterine cavity may be passed spontaneously through the vagina or might need a procedure to help remove it.
- The procedure may not be possible due to medical and/or technical reasons.

Rare risks and complications include:

- The blockage of non uterine arteries potentially causing damage to pelvic structures, nerves and legs. This may require further treatment.
- When a blood vessel is embolised, some of the tissue supplied by that blood vessel may become damaged. A hysterectomy could be required.
- Irreversible damage to the ovaries causing infertility and menopause.
- Incomplete blockage of the blood flow. This may require further procedures.
- An increased lifetime cancer risk due to the exposure to x-rays.
- Skin burns or damage from exposure to x-rays.
- Seizures and/or cardiac arrest due to local anesthetic toxicity.
- Death as a result of this procedure is very rare.

Note: Research to date is not clear what effect uterine artery embolisation has on fertility and future pregnancies.

مخاطر ومضاعفات شائعة ، وتشمل:

- ألم بسيط ، كدمة و/أو عدوى عند منطقة دخول الإبرة الوريدية . قد يتطلب المعالجة بمضادات حيوية.
- ألم أو الشعور بعدم الراحة في منطقة دخول القسطرة . قد يتطلب ذلك المعالجة بالأدوية.
- حدوث نزيف أو كدمة . عادة ما يشفى ذلك بوضع ضغط و/أو كمادات ثلج على موضع دخول القسطرة . يحدث ذلك بشكل أكثر شيوعاً عند من يتناولون أدوية الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايبيبريدامول (بيرسانتين أو اساسانتين) .
- "متلازمة ما بعد الانصمام" وتشمل ألم ، غثيان ، تقيؤ ، وارتفاع في درجة الحرارة . تتطلب العلاج بمضادات حيوية وأدوية مضادة للألم.
- فشل في عمل المخدر الموضعي مما قد يتطلب إعطاء حقنة أخرى منه ، أو استخدام أسلوب تخدير آخر.
- ضرر لعصب . عادةً ما يكون ذلك مؤقتاً ، ومن المفترض تحسنه مع الوقت . من النادر حدوث ضرر دائم للعصب.

مخاطر ومضاعفات أقل شيوعاً ، وتشمل:

- عدوى تتطلب مضادات حيوية وعلاجات أخرى.
- ضرر للأنسجة المحيطة بالأوعية الدموية ، الأعضاء الأخرى والعضلات وتتطلب معالجات أخرى.
- خثرة دموية أو نزيف مفرط من منطقة دخول القسطرة . قد يتطلب ذلك معالجات أخرى و/أو جراحة تصحيحية.
- رد فعل تحسسي لأي من الأدوية المعطاة . يتطلب ذلك علاجات أخرى.
- انفصال بعض الأنسجة من جدار الرحم إلى تجويف الرحم . قد تخرج هذه الأنسجة تلقائياً عن طريق المهبل ، أو قد تتطلب إجراءً للمساعدة على إخراجها.
- قد لا يكون القيام بالإجراء ممكناً لأسباب طبية و / أو فنية (تقنية).

مخاطر ومضاعفات نادرة الحدوث ، وتشمل:

- حدوث انغلاق في غير شرايين الرحم مما يرجح حدوث ضرر لمكونات الحوض ، الأعصاب والساقين . قد يتطلب ذلك علاجات أخرى.
- بعد سد وإغلاق الشريان ، فقد يحدث ضرر لبعض الأنسجة التي تتغذى بالدم عن طريقه . قد تكون هناك حاجة لاستئصال الرحم.
- ضرر دائم غير قابل للتصحيح للمبايض مسبباً العقم وانقطاع الطمث (الدورة الشهرية).
- عدم الإغلاق الكامل لتدفق الدم . قد يتطلب ذلك إجراء آخر.
- زيادة مخاطر الإصابة بالسرطان خلال حياة المريض بسبب التعرض للأشعة السينية.
- حروق أو ضرر يصيب الجلد بسبب التعرض للأشعة السينية.
- تشنجات و/أو سكتة قلبية بسبب سمية المادة المستخدمة في التخدير الموضعي.
- الوفاة نادرة جداً بسبب هذا الإجراء.

ملحوظة: حتى هذه اللحظة ، لم تبين الأبحاث تأثير انصمام الشريان الرحمي على الإصابة بالعقم والقدرة على الحمل.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

If sedation is given extra risks include:

- Faintness or dizziness, especially when you start to move around
- Fall in blood pressure nausea and vomiting
- weakness
- An existing medical condition getting worse
- Heart and lung problems such as heart attack or vomit in the lungs causing pneumonia. This may require emergency treatment
- Stroke resulting in brain damage.

8. What are the safety issues when you leave hospital?

- Go to your nearest Emergency Department or GP if you become unwell or have;
- A cool or cold limb
- Uncontrolled pain and/or nausea
- Continuous bleeding or swelling at the puncture site
- Redness or inflammation at the puncture site a fever, higher than previously experienced
- Other warning signs the doctor may have asked you to be aware of.

Notes to talk to my doctor/health practitioner about:

مخاطر إضافية عند استخدام الدواء المسكن:

- إغماءة أو دوخة ، خاصة عند بدء الحركة بعد الانتهاء من الإجراء.
- انخفاض في ضغط الدم. غثيان وقيئ.
- ضعف عام.
- تفاقم أي مشكلة صحية أخرى.
- مشاكل في القلب والرئتين كالأزمة القلبية أو دخول المادة المتقيئة إلى الرئة
- مسببة التهاب رئوي مما قد يتطلب تدخل طبي طارئ.
- سكتة دماغية تتسبب في ضرر للمخ.

8. ما هي الأمور المتعلقة بالسلامة بعد مغادرة المستشفى؟

توجه لأقرب قسم الطوارئ أو اتصل بطبيبك العام إذا شعرت بأنك لست على ما يرام أو شعرت بالتالي :

- فتور أو برودة في أحد الأطراف.
- ألم وأو غثيان خارجان عن السيطرة.
- نزيف مستمر أو تورم مستمر في موضع دخول القسطرة.
- احمرار أو التهاب في موضع دخول القسطرة .
- ارتفاع في درجة الحرارة بشكل أكبر مما كان عليه الأمر من قبل.
- ملاحظة أيأ من الأعراض التي حذرك الطبيب منها وطلب منك التنبيه لها.

أمور أتناقش حولها مع طبيبي:
